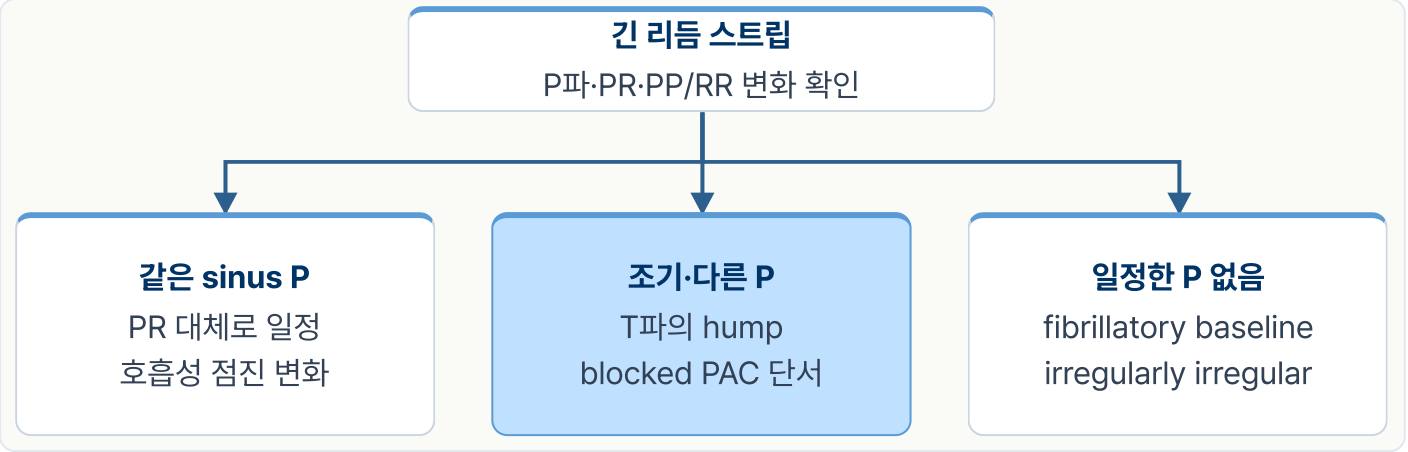
의료진 진료 카드 · ASL-004

느린 맥·휴지기 · P파부터 확인

연자 Q&A의 감별 포인트: 같은 P파가 있는지, 조기에 나온 다른 P파가 T파에 숨어 있는지 본다.

불규칙한 RR · P파의 형태와 시점으로 분기



연자 Q&A · 긴 PP의 해석

동성부정맥	가장 긴 PP와 짧은 PP 차이 약 120~160ms로 인지하지만 병적 상태를 가르는 ms 경계값은 없다. 같은 P파, 호흡에 따라 점진적으로 길어졌다 짧아지는 경향.
연령·증상	50~60대에 보인다는 사실만으로 동결절 질환을 뜻하지 않는다. 증상·평균 심박수·pause·변시성 기능부전(chronotropic incompetence)을 함께 본다.

연자 Q&A · pause와 blocked PAC

숨은 P파	Blocked PAC는 T파 안에 조기 P파의 hump가 숨어 pause처럼 보일 수 있다. 동성부정맥·실제 pause와 감별한다.
치료 방향	연자는 심한 pause는 박동기, blocked PAC는 항부정맥제로 치료 방향이 달라 감별이 중요하다고 답변. coarse AF·빈번한 PAC로 혼동되면 긴 스트립이 도움.

완전 방실차단(complete AV block) 또는 급성 심근경색은 즉시 의뢰. 느리게 느껴지는 맥은 PVC에서도 생길 수 있으므로 리듬을 기록해 확인한다.

의료진 진료 카드 · ASL-004

서맥성 소견 · 관찰과 의뢰

본강의의 생리적 수면 중 차단과 Wenckebach 사례를, 증상·기저 심질환이 있는 경우와 구분한다.

본강의 · 정밀검사·의뢰가 불필요했던 사례

수면 중 차단

48세 남자, 새벽 4시 수면 중 미주신경 긴장 증가에 따른 차단. 연자는 생리적 반응으로 설명하며 해당 사례에서 별도 정밀검사·의뢰가 불필요하다고 했다.

Wenckebach

검진에서 발견된 Wenckebach 차단 사례도 양성 경과로 설명. 동반 LVH가 있다면 부정맥 자체보다 LVH 평가가 더 중요하다고 강조.

연자 Q&A · 증상과 기록을 보고 의뢰

심한 증상	실신·전실신, 심한 흉통·호흡곤란, 심계항진 때 매우 빠른 심박수(예: 200 bpm).
유의한 기록	고도 AV block, sustained SVT/VT 등 유의한 부정맥. 구조적 심질환·심부전·심근경색이 의심되거나 echo로 확인된 경우.
기록이 안 될 때	심한 증상에도 진단이 되지 않아 장기 모니터링·EPS가 필요한 경우. 12유도 ECG와 Holter/patch로 증상과 리듬의 연관을 먼저 확인.

본강의·연자 Q&A · 함께 볼 소견

PVC	맥이 건너뛰거나 느리게 느껴짐. 부담률은 Holter/patch, 심기능은 echo로 평가한다.
AF	P파 부재와 불규칙한 심실 반응. 본강의는 빈맥·서맥 증후군의 실신도 증상으로 제시했다.
차단 소견	강의 요약은 완전 AV block의 즉시 의뢰와 Wenckebach·1도 AV block을 구분했다. 수면 중 차단의 생리적 맥락도 함께 읽는다.

연자 Q&A: 동성부정맥은 간격 숫자 하나보다 P파 형태, 호흡성 변화, 증상·평균 맥박·휴지기·운동 시 심박수 반응을 종합해 해석한다.